



Manual de Admissão e Pré-operatório

Documento educacional baseado em referências reconhecidas de segurança do paciente. Não representa protocolo de uma instituição específica.

Finalidade

Orientar a conferência inicial do paciente cirúrgico de forma compatível com princípios reconhecidos de segurança do paciente. Este material é educacional e não substitui protocolo institucional, prescrição, avaliação médica ou anestésica.

1. Identificação segura do paciente

A identificação deve ser confirmada antes de cuidados, procedimentos, administração de medicamentos, coleta de exames e transferência.

Utilizar pelo menos dois identificadores, como nome completo e data de nascimento ou outro identificador institucional. Número do quarto ou localização do paciente não deve ser usado como identificador único.

Conferir os dados verbalmente com o paciente quando possível e compará-los com pulseira, prontuário e documentação disponível.

Em caso de divergência de identificação, interromper o fluxo relacionado ao procedimento até esclarecimento.

2. Avaliação inicial e informações relevantes

Registrar ou confirmar alergias e reações prévias, medicamentos em uso, comorbidades relevantes, procedimentos anteriores e outras informações previstas na avaliação institucional.

Alterações clínicas, sinais ou sintomas inesperados e informações relevantes não documentadas devem ser comunicados à equipe responsável antes do procedimento.

Os sinais vitais devem ser verificados conforme avaliação clínica e rotina institucional, com registro no prontuário.

3. Alergias

Perguntar ativamente sobre alergias a medicamentos, alimentos, látex, antissépticos, adesivos e outros materiais quando aplicável.

Registrar a alergia e, quando conhecida, a reação apresentada. A informação deve estar visível à equipe de acordo com o sistema de identificação adotado pelo serviço.

Uma alergia conhecida deve ser comunicada à equipe antes da administração de medicamentos ou exposição ao agente relacionado.

4. Procedimento, paciente e local corretos

Antes do procedimento, confirmar identidade do paciente, procedimento planejado e, quando aplicável, o local/lado correto.

A demarcação do sítio cirúrgico deve seguir o protocolo institucional e ser realizada pelo profissional definido pelo serviço, com participação do paciente sempre que possível.

Qualquer divergência entre paciente, agenda, prontuário, consentimento ou marcação deve ser resolvida antes de prosseguir.

5. Documentação pré-operatória

Verificar a presença dos documentos exigidos pelo serviço, incluindo registros clínicos, avaliações e termos de consentimento aplicáveis.

Pendências não devem ser 'regularizadas' com informação presumida. A equipe responsável deve ser acionada e a conduta registrada.

O prontuário é documento assistencial, legal, sigiloso e de comunicação entre profissionais; os registros devem ser claros, datados e compatíveis com a assistência prestada.

6. Transferência para o centro cirúrgico

Antes da transferência, realizar a conferência prevista pelo serviço: identificação, procedimento, documentação, alergias, condições clínicas relevantes, preparo realizado e comunicação de pendências.

A transferência de informações deve ser objetiva e suficiente para continuidade segura do cuidado.

Se houver inconsistência relevante que possa comprometer a segurança, o fluxo deve ser interrompido até avaliação da equipe responsável.

Referências-base

- Ministério da Saúde / ANVISA / Fiocruz - Protocolos Básicos de Segurança do Paciente: identificação do paciente, cirurgia segura, prevenção de quedas e segurança no uso de medicamentos.
- RDC ANVISA nº 36/2013 - ações para segurança do paciente em serviços de saúde.
- Conselho Federal de Medicina - Resolução CFM nº 1.638/2002 (prontuário médico) e Recomendação CFM nº 1/2016 (consentimento livre e esclarecido).
- American Society of Anesthesiologists - Practice Guidelines for Preoperative Fasting (referência internacional para jejum em procedimentos eletivos; aplicação depende da avaliação anestésica e do protocolo institucional).

Nota de uso: material preparado para projeto acadêmico de RAG. Na assistência real, prevalecem legislação vigente, protocolos institucionais e avaliação dos profissionais responsáveis.